IMSS

Dirección de Prestaciones Médicas

Coordinación de Proyectos Especiales en salud

Guía Operativa para la Evacuación de hospitales y sus áreas críticas

Índice

Índice 2
Directorio 4
Objetivo General 5
Ámbito de aplicación 5
Alcance 6
Definiciones clave 6
Principios generales de actuación 7
Procedimiento operativo para la evacuación de hospitales 9
Acciones durante la fase de preparación y alistamiento 9
1) Designación y conformación del equipo responsable 9
2) Análisis estratégico de riesgos y vulnerabilidades 10
3) Definición de rutas de evacuación, zonas de seguridad y puntos clave 10
4) Actualización de directorios 11
5) Capacitación, entrenamiento y simulacros 11
6) Preparación de recursos materiales e insumos 11
7) Integración al Plan Hospitalario de Respuesta a Emergencias y Desastres 12
Actividades durante la respuesta 12
1. Notificación Inicial y activación del alertamiento 12
2. Organización y Asignación de Roles 14
3. Ejecución ordenada de la evacuación 15
4. Atención en la Zona de seguridad interna 15
5. Atención en la Zona de seguridad externa 17
Cierre de la fase de respuesta y recuperación 20
Anexos 22
Anexo 1. Flujograma: 22
Anexo 2. Algoritmo para realizar el triage para evacuación de áreas críticas 23
Referencias 24
Recursos 25
Contacto 26

Este documento fue elaborado por la **Coordinación de Proyectos Especiales en Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS** e incorpora recomendaciones de organismos nacionales e internacionales y mejores prácticas basadas en la evidencia sobre gestión de emergencias en salud y la preparación y ejecución del proceso para la evacuación hospitalaria y sus áreas críticas, en concordancia con los Ítems 27, 36, 112-123, 125-127, 132, 135, 138, 141-143, 145,147, 150 del Índice de Seguridad Hospitalaria 2da versión, del Programa Hospital Seguro.

Es responsabilidad de cada establecimiento de salud adaptar las recomendaciones aquí vertidas, considerando sus capacidades, recursos, nivel de atención, análisis de riesgos y condiciones particulares, bajo el criterio técnico y profesional del personal responsable, priorizando la seguridad de pacientes, personal y la continuidad de los servicios.

Derechos reservados © 2026
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos patrimoniales.

Directorio

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto
Dirección General

Dr. Jorge Gaviño Ambriz
Secretaría General

Dra. Alva Alejandra Santos Carrillo
Dirección de Prestaciones Médicas

Dr. Mauricio Hernández Ávila
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

Mtro. Borsalino González Andrade
Dirección de Administración

Lic. Luisa Obrador Garrido Cuesta
Dirección de Incorporación y Recaudación

Mtra. Norma Gabriela López Castañeda
Dirección Jurídica

Mtra. Claudia Laura Vázquez Espinoza
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Mtro. Marco Aurelio Ramírez Corzo
Dirección de Finanzas

Lic. Javier Guerrero García
Dirección de Operación y Evaluación

Mtro. Arturo De Lucio Ortega
Dirección de Planeación para la Transformación Institucional

Dra. Janett Alvarado González
Coordinación de Proyectos Especiales en Salud

Objetivo General

Establecer un procedimiento operativo estandarizado que permita al personal directivo del IMSS, planear y ejecutar de forma segura, coordinada y eficiente la evacuación parcial o total de sus ocupantes (pacientes, personal y visitantes) ante la ocurrencia de una emergencia o desastre, mediante:

- El análisis de la situación y la toma oportuna de la decisión de evacuar.
- La clasificación y priorización de pacientes para la evacuación (triage para la evacuación).
- La accesibilidad y seguridad de las rutas de evacuación (principal y alterna) y de las zonas de seguridad (interna y externa).
- La disposición de recursos humanos, equipamiento y apoyos técnicos que minimicen los riesgos durante el traslado.
- La coordinación institucional e interinstitucional, en el marco de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS).
- Dentro del contexto de la implementación del Plan Hospitalario de Respuesta ante Emergencias y Desastres (PH-RED).
- La capacitación continua del personal, incluyendo la realización sistemática de simulacros y ejercicios de simulación a través del trabajo colaborativo entre UIPC y personal del área médica.

Ámbito de aplicación

Esta guía aplica a unidades de primer nivel, unidades de segundo nivel como hospitales generales y regionales, Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), y se articula con el Plan Hospitalario de Respuesta a Emergencias y Desastres (PH-RED), el Programa Interno de Protección Civil (PIPC) así como con los planes de contingencia para riesgos específicos.

Alcance

El presente documento está dirigido al personal directivo y a los integrantes del Comité de Emergencias y Desastres de los Establecimientos de Salud, Unidades Internas de Protección Civil y a todo el personal que participa en la gestión Integral del Riesgo de Desastres, quienes intervienen en el diseño, desarrollo, implementación y actualización de los Planes de Respuesta Hospitalaria.

Definiciones clave

Áreas críticas: Servicios o unidades con alta capacidad resolutiva y vulnerabilidad elevada, que requieren priorización absoluta en la planificación de evacuación y en la asignación de recursos durante emergencias (como urgencias, cuidados intensivos (adultos, neonatales, pediátricos), quirófanos, tococirugía y hemodiálisis.

Binomio médica/o-enfermera/o: Equipo básico operativo (médica/o + enfermera/o) asignado para el manejo, estabilización y traslado de pacientes durante evacuaciones, especialmente en áreas críticas.

CVOED: Es el Centro Virtual de Operaciones de Emergencias y Desastres, administrado por la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud.

Evacuación hospitalaria: Traslado organizado de pacientes, familiares, visitantes y personal desde áreas de alto riesgo hacia zonas seguras internas o externas, utilizando rutas verificadas para proteger la vida, minimizar riesgos adicionales y preservar en lo posible la continuidad de la atención crítica.

Puesto de Mando: (PM) Estructura de dirección y coordinación interna del hospital que activa el plan de respuesta, toma decisiones estratégicas, distribuye recursos, supervisa la ejecución de acciones y mantiene comunicación con niveles tácticos, operativos y externos (incluyendo el centro regulador de Urgencias).

RISS: Red Integrada de Servicios de Salud. Red de establecimientos de salud organizados para proveer servicios de salud a una población definida, mediante la articulación

progresiva y coordinada de los recursos con el propósito de garantizar el acceso continuo, oportuno, integral y de calidad.

Ruta de evacuación: Camino o secuencia de vías (primaria y alternativa) señalizadas, despejadas, iluminadas y accesibles, diseñadas específicamente para permitir la salida rápida y segura desde cualquier punto del establecimiento hacia una zona de seguridad interna o externa.

Triage de evacuación: Clasificación rápida de pacientes por riesgo y movilidad para priorizar traslados seguros, utilizando categorías A-D.

Zona de seguridad externa: Área abierta, externa al edificio y alejada de zonas de riesgo inmediato (colapso, incendio, inundación, etc.), designada como punto de reunión y concentración de evacuados que debe tener condiciones mínimas para la continuidad de tratamientos vitales, acceso vehicular para ambulancias y equipos de respuesta externa, y estar señalizada y preparada para recibir a pacientes, personal y familiares de forma ordenada.

Zona de seguridad interna: Espacio o sector dentro del propio establecimiento de salud, que ofrece condiciones de seguridad estructural y no estructural frente a la amenaza específica y que debe contar con suministros básicos de emergencia y accesibilidad. Sirve para resguardo temporal y protección de la vida mientras se efectúa la evacuación del paciente, permitiendo mantener la atención crítica en lo posible.

Principios generales de actuación

a) Priorización de la vida y la seguridad: Siempre se debe proteger en primer lugar la vida de las personas ocupantes de las instalaciones (pacientes, personal de salud y visitantes), seguido de los bienes y la infraestructura. Esto implica evacuarlos del establecimiento de manera ordenada y sin comprometer su salud y seguridad durante el traslado.

b) Definición clara de roles y responsabilidades: Definir una estructura operativa con un Comité de Emergencias, brigadas de evacuación y coordinadores de brigada y coordinadores Médicos. Cada persona debe conocer su función, los códigos para la activación del alertamiento, guiar evacuaciones o coordinar con servicios externos (bomberos, ambulancias). El plan debe ser realista, basado en la capacidad real del hospital.

c) Gestión de sistemas de detección y alertamiento temprano: Implementar sistemas básicos de seguridad, incluyendo detección de amenazas (incendios, sismos), alerta inmediata, alarmas audibles y visuales, y señalización de rutas de evacuación, las cuales deben ser incluyentes para personas con discapacidad La evacuación debe iniciarse solo cuando sea necesaria, evaluando si es parcial o total.

d) Establecer rutas de evacuación: claras, señalizadas, accesibles y libres de obstáculos, así como zonas de seguridad interna o externa para concentración de pacientes y continuidad de tratamiento de manera temporal. Es importante identificar a las personas con discapacidad que laboran en el establecimiento para garantizar su seguridad y una evacuación adecuada para todos de acuerdo con la NOM-008-SSPC-2015.

e) Comunicación efectiva: Mantener protocolos de comunicación interna (radios, altavoces, telefonía celular y CVOED) y externa (con autoridades locales). Informar de manera clara y concreta, incluyendo actualizaciones durante la evacuación.

f) Entrenamiento y simulacros regulares: Realizar evaluaciones rutinarias, simulacros, ejercicios de simulación y capacitaciones para el personal. Esto asegura que el plan sea dinámico y se actualice basado en lecciones aprendidas.

g) Coordinación interinstitucional: Integrar el plan con la red hospitalaria institucional y con otras instituciones de salud públicas y privadas, protección civil y servicios de emergencia para traslados masivos. Posterior a la evacuación, realizar una evaluación estratégica de daños, y planear el retorno a la normalidad, incluyendo apoyo psicológico.

h) Evaluación y clasificación de pacientes: Clasificar a los pacientes considerando la autonomía para la movilidad, nivel de gravedad y el riesgo de desplazamiento para optimizar la evacuación facilita una evacuación segura, ordenada y eficaz, maximizando la supervivencia, la continuidad de la atención y el uso racional de los recursos disponibles en un contexto de alta presión operativa.

Procedimiento operativo para la evacuación de hospitales

El Procedimiento Específico para la Evacuación de hospitales establece los lineamientos operativos para proteger la vida y la integridad de las y los pacientes y visitantes ante una emergencia o desastre que comprometa la seguridad de la unidad. Se fundamenta en la evaluación de riesgos y la identificación de vulnerabilidades del establecimiento de salud y define los criterios para una evacuación segura, ordenada y coordinada, facilitando la continuidad de la atención bajo el principio de no dejar a nadie atrás, considerando las necesidades de las personas con discapacidad.

El procedimiento integra la identificación de rutas de evacuación y zonas de seguridad (interna y externa), los mecanismos de alertamiento y comunicación, la asignación clara de roles y responsabilidades, la disponibilidad de recursos humanos y materiales, y la coordinación con servicios externos de apoyo. Asimismo, contempla la capacitación del personal, la puesta a prueba del procedimiento mediante la realización de ejercicios de simulación y simulacros, así como la evaluación posterior del evento, como elementos clave para fortalecer la preparación institucional y la mejora continua de la respuesta ante emergencias.

Acciones durante la fase de preparación y alistamiento

1) Designación y conformación del equipo responsable

Designar un equipo multidisciplinario (personal directivo, integrantes del comité hospitalario de emergencias, Unidad interna de protección Civil y responsables de la gestión del riesgo de emergencias en salud y desastres) para la planeación, desarrollo y actualización del procedimiento de evacuación.

2) Análisis estratégico de riesgos y vulnerabilidades

Realizar un análisis de riesgos del hospital, con un enfoque multiamenaza (sismos, incendios, inundaciones, amenazas químicas/radiológicas, explosivos, entre otras.) mediante las herramientas disponibles (por ejemplo, STAR-H, matriz de probabilidad-impacto, Método de Mosler, entre otras). Idealmente, el hospital debe haber sido evaluado para la identificación de vulnerabilidades estructurales, no estructurales y de organización en el marco del programa Hospital Seguro y atendiendo las recomendaciones del equipo multidisciplinario.

Identificar zonas de alto riesgo y priorizando áreas críticas (urgencias, extensión hospitalaria, unidades de cuidados intensivos, quirófanos, neonatología, hemodiálisis, laboratorio, banco de sangre, entre otras).

3) Definición de rutas de evacuación, zonas de seguridad y puntos clave

- Establecer al menos dos rutas de evacuación por área/unidad: principal y alterna (horizontal, vertical, parcial o total según el escenario). En este punto deben considerarse soluciones como puentes temporales y la identificación de zonas que sean factibles de derribar para crear rutas alternas de evacuación en caso de incendios o colapso estructural parcial y los puntos de extracción en caso de operaciones de rescate.

- Rutas accesibles, señalizadas y libres de obstáculos en todo momento.

- Delimitar zonas de seguridad interna (dentro del edificio, si la amenaza lo permite) y zonas de seguridad externa (puntos de reunión seguros fuera del hospital).

- Identificar puntos de reubicación temporal y hospitales de apoyo en la red integrada de servicios de salud (RISS). Establecimiento de convenios y acuerdos sectoriales: hospitales IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Secretaría de Salud, privados, y otros, así como acuerdos intersectoriales: Protección Civil, bomberos, ambulancias, sistemas de traslado prehospitalario, policía, guardia Nacional y redes de apoyo logístico.

4) Actualización de directorios

Es importante actualizar los directorios y números de contacto de servicios de emergencias, instituciones, autoridades institucionales, CVOED, credenciales de acceso a la plataforma informática del CVOED, así como designar a un responsable (enlace CVOED) por turno para el manejo del notificador de emergencias.

5) Capacitación, entrenamiento y simulacros

- Establecer un cronograma de capacitación obligatoria para el personal de todas las categorías, incluyendo a los participantes en grupos para la gestión del riesgo de emergencias en salud y desastres, primera ayuda psicológica (PAP), (incluyendo brigadas de evacuación, personal de áreas críticas y directivos) en colaboración con unidad interna de protección civil.
- Realizar al menos dos simulacros anuales (en todos los turnos), con énfasis en evacuación de áreas críticas.
- Incluir escenarios diversos y con base en la evaluación de riesgos (incendio, sismo, amenaza química, y otros.).
- Evaluar cada simulacro y el desempeño de los participantes para identificar áreas de oportunidad y actualizar el procedimiento operativo.
- Familiarizar al personal con el uso de equipos de soporte vital y dispositivos de apoyo (camillas, sillas de ruedas, ventiladores portátiles, y otros.).

6) Preparación de recursos materiales e insumos

- Gestionar equipos e insumos necesarios: camillas para evacuación, bolsas de transporte (dispositivos flexibles tipo arrastre para pacientes no ambulatorios), equipo de protección personal, sistemas de comunicación alternos (radios, telefonía celular).
- Preparar kits para áreas críticas (antídotos de intoxicaciones más frecuentes en la región, tanques de oxígeno portátil, equipo para estabilización espinal, equipo para manejo avanzado de la vía aérea, medicamentos para reanimación, y otros).
- Verificar disponibilidad de ambulancias para traslado de pacientes y si se cuenta con una zona que permita el flujo unidireccional de ambulancias (noria de ambulancias), considere establecer un mecanismo de control vehicular fuera de

las instalaciones del establecimiento de salud para facilitar el flujo de vehículos de emergencia.

7) Integración al Plan Hospitalario de Respuesta a Emergencias y Desastres

Este procedimiento operativo estandarizado, debe incluirse en el Plan Hospitalario de Respuesta a Emergencias y Desastres y debe estar adaptado a las características, complejidad y capacidades de cada hospital

• Actualizar periódicamente (o al menos una vez al año) el plan con base en lecciones aprendidas de simulacros, incidentes reales y evaluaciones con el índice de Seguridad Hospitalaria.

Actividades durante la respuesta

1. Notificación Inicial y activación del alertamiento

   i. Detección y alerta inmediata: Al identificar la amenaza (incendio, sismo, fuga, etc.), el director de la unidad o, máxima autoridad presente activará el código para la evacuación (alarma sonora/lumínica audible en todo el hospital), y el tipo de evacuación (total o parcial, horizontal o vertical).

   ii. Activar cadena de llamadas: Informar inmediatamente y de manera obligatoria a autoridades institucionales (CVOED-IMSS, autoridades delegacionales) a autoridades externas (Protección Civil, bomberos).

   iii. De manera inmediata se debe activar al comité Hospitalario de Emergencias (CHE) y la Unidad Interna de Protección Civil (UIPC).

   iv. Triage para evacuación: Iniciar triage rápido dinámico en todas las áreas considerando la autonomía de los pacientes para ejecutar la evacuación, necesidad de apoyo mecánico ventilatorio, requerimientos de oxígeno, nivel de conciencia y gravedad. Con este enfoque se pueden establecer 5 grupos de pacientes en orden de prioridad para la evacuación:

      - **Grupo 1.** Pacientes estables o en prealta, sin soporte ventilatorio ni hemodinámico, capaces de desplazarse por sus propios medios o con apoyo mínimo de familiares. Requieren pocos recursos y pueden ser evacuados en grupos bajo supervisión del personal de enfermería o brigadas de evacuación.

- **Grupo 2.** Pacientes que no pueden desplazarse de forma autónoma, sin ventilación mecánica, algunos con dificultad respiratoria leve a moderada que responde al oxígeno suplementario. Requieren apoyo directo del personal de enfermería o brigadas, así como dispositivos de movilidad (camillas, sillas de ruedas) para su traslado seguro.
- **Grupo 3.** Pacientes con ventilación mecánica en parámetros bajos o ventilación no invasiva, con o sin apoyo vasoactivo a dosis bajas, sin necesidad de terapias extracorpóreas. Presentan gravedad moderada o baja, y su traslado puede realizarse con recursos convencionales, siempre que siempre que exista monitoreo y personal capacitado.
- **Grupo 4.** Pacientes en ventilación mecánica con parámetros elevados y soporte vasoactivo moderado, dependientes de sedación y soporte hemodinámico, pero sin criterios de falla orgánica múltiple o muerte cerebral. Su evacuación representa un alto reto operativo, ya que requiere gran cantidad de recursos, personal médico especializado y enfermería o paramédicos altamente entrenados. a monitoreo y personal capacitado.
- **Grupo 5.** Pacientes para los cuales no se recomienda la evacuación en un primer momento, debido a que el riesgo del traslado supera claramente el beneficio, tanto para el propio paciente como para el personal de salud. Se trata de pacientes con inestabilidad extrema, dependencia de soporte vital avanzado sin respuesta adecuada, o con pronóstico vital muy limitado. Incluye pacientes con:
    - Parámetros ventilatorios críticos ($PaO_2/FiO_2 < 150$, PEEP > 12).
    - Dosis altas de vasopresores (> 0.5 µg/kg/min) sin respuesta clínica.
    - Insuficiencia orgánica múltiple o diagnóstico de muerte cerebral.
    - Lesiones traumáticas exanguinantes no controladas.
    - Vía aérea no permeable o no asegurada.
    - Soporte con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).
    - Situación inmediata de postrasplante de órganos vitales (hígado, corazón, pulmón) en fase crítica.

Estos pacientes deben permanecer en sitio mientras existan condiciones mínimas de seguridad, priorizando cuidados paliativos, soporte ético y toma de decisiones clínicas colegiadas. Su evacuación solo debe considerarse de manera diferida, excepcional y bajo criterios estrictos de seguridad, para evitar un incremento del número de víctimas. Estas decisiones deberán documentarse de manera explícita en el expediente clínico y, siempre que las condiciones lo permitan, comunicarse de forma clara y oportuna a los familiares o responsables legales del paciente, conforme a los principios éticos, legales y de seguridad del paciente.

Para los pacientes en una intervención quirúrgica se debe ejecutar un protocolo de control de daños antes de iniciar la evacuación.

2. Organización y Asignación de Roles

i. Activación de brigadas: Desplegar brigadistas capacitados (evacuación y repliegue, primeros auxilios, prevención y combate de incendios, búsqueda y rescate, comunicación, brigadas especiales) y personal sanitario experto en gestión del riesgo de desastres, por piso o área clínica.
ii. Actividades operativas: Asignar binomios o equipos multidisciplinarios (médico-enfermería-terapeuta respiratorio) para la evacuación de pacientes del grupo 3; especialistas para pacientes graves de los grupos 4 y 5 (monitoreo continuo, bombas de infusión, ventiladores). En neonatología/Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN): equipo dedicado para incubadoras portátiles y control térmico.
iii. Responsabilidades: Jefa/e de piso supervisan desalojo basados en censo nominal de pacientes y triage para evacuación; personal médico prepara traslados seguros.
iv. En caso de que los recursos institucionales sean insuficientes para el traslado eficiente y oportuno de pacientes (por ejemplo, en una evacuación total), se debe coordinar el traslado de pacientes de manera oportuna y estructurada con apoyo externo (servicios de emergencia, instituciones del sector salud, Protección Civil y proveedores de ambulancias). Dicha coordinación deberá realizarse conforme a los roles, responsabilidades y canales de comunicación previamente definidos en el Plan Hospitalario de Respuesta a Emergencias.

3. Ejecución ordenada de la evacuación

i. Rutas y métodos:
   - Seguir rutas predefinidas, señalizadas, con iluminación de emergencia y libres de obstrucciones.
   - Priorizar evacuación horizontal (mismo piso a zona segura interna) antes que vertical (escaleras/rampas; evitar ascensores en incendios o fallas eléctricas).
   - El o los brigadistas de evacuación, guiarán el desalojo del establecimiento para visitantes, personal del hospital y pacientes con autonomía para la deambulación, garantizando la seguridad de las rutas de evacuación.

   .

ii. Insumos y recursos: camillas, sillas de evacuación, ventiladores portátiles, bolsas válvula-mascarilla, tanques de oxígeno, bombas portátiles, equipo de emergencia).

En áreas críticas:

- Verificar estabilidad antes de movilizar; mantener soporte vital sin interrupciones (ventilación manual durante desconexión). Acciones para la seguridad del paciente: posición adecuada para intubados, camillas con frenos, descenso controlado.
- Mujeres embarazadas o puérperas: acompañamiento de enfermera y/o médico de acuerdo con el riesgo obstétrico y riesgo para el producto.
- Neonatos/pediátricos: incubadoras portátiles con verificación de temperatura y funcionamiento.
- Responsabilidades: Brigadistas guían filas ordenadas a través de rutas de evacuación, verifica seguridad de estas, asisten a personas vulnerables y verifican que nadie quede atrás (conteo rápido).

4. Atención en la Zona de seguridad interna

Las zonas de seguridad interna cumplen una función clave como áreas de estabilización, preparación y control antes del traslado definitivo a otra unidad hospitalaria. No son solo puntos de espera: son espacios clínico-operativos activos, que sirven como áreas de expansión de capacidades y que deben contar con personal asignado durante la

evacuación hospitalaria. El personal asignado debe estar capacitado para identificar complicaciones agudas y tratarlas oportunamente además de ejecutar las acciones de estabilización previas al traslado definitivo.

Funciones esenciales que deben realizarse en estas zonas:

i. Actividades para la seguridad del paciente:

• Verificar identidad (pulsera/etiqueta); efectuar revisión primaria (A: vía aérea, B: patrón respiratorio, C: circulación, D: disfunción neurológica) y secundaria para detectar deterioro o lesiones nuevas.

• Proporcionar soporte vital inmediato (oxígeno, medicamentos, ventilación, control hemodinámico, manejo de dolor).

• Registrar en formatos estandarizados: nombre, hora de traslado, evolución, incidencias (hipoxemia, hipotermia, etc.), equipo involucrado.

i.Priorizar reconexión rápida a equipos fijos para minimizar complicaciones.

ii. Estabilización clínica previa al traslado: antes de autorizar la evacuación definitiva, en la zona de seguridad interna se debe:

- Verificar y optimizar la estabilidad hemodinámica y respiratoria.
- Ajustar parámetros ventilatorios, sedación y analgesia.
- Corregir alteraciones críticas potencialmente reversibles (hipotensión, hipoxemia, arritmias, hipoglucemia).
- Se debe confirmar que el paciente se encuentra en el mejor estado posible para tolerar el traslado.

iii. Aseguramiento de la vía aérea y dispositivos críticos:

- Confirmar vía aérea permeable y asegurada (tubo endotraqueal bien fijado, traqueostomía protegida).
- Revisar fijación y funcionamiento de: Accesos venosos centrales y periféricos, líneas arteriales, sondas, drenajes y catéteres
- Verificar autonomía de equipos portátiles (baterías, oxígeno).
- Preparación del soporte vital para transporte:
- Realizar el cambio planificado a equipos de transporte (ventilador portátil, bombas de infusión).
- Verificar redundancia mínima (oxígeno de reserva, batería secundaria).
- Verificar la identificación de medicamentos en infusión continua.

- Confirmar compatibilidad del equipo con el medio de traslado (ambulancia terrestre, aérea).

iv. Reevaluación y clasificación final para evacuación:
- Confirmar o reclasificar al paciente dentro del esquema de evacuación (Grupo 3, 4 o 5).
- Reevaluar riesgo–beneficio del traslado inmediato.
- Documentar criterios clínicos que justifican la evacuación o su diferimiento.
- Activar, si aplica, decisiones colegiadas (médico tratante, Unidad de Cuidados Intensivos, jefatura (s) correspondientes (s), comité de emergencias).

v. Coordinación operativa y logística del traslado:
- Confirmar unidad receptora, cama disponible y nivel de atención.
- Coordinar con el sistema de ambulancias y CRUM/COE correspondiente.
- Definir equipo humano de traslado (personal médico, de enfermería, paramédico).
- Sincronizar el tiempo de salida para evitar esperas prolongadas o traslados improvisados.
- Asegurar envío físico o digital de: notas médicas relevantes, estudios indispensables, consentimientos informados (cuando aplique).
- Informar a familiares sobre estado, destino y condiciones del traslado.

vi. Trazabilidad y control institucional:
- Registrar hora de ingreso y egreso.
- Identificar plenamente al paciente (nombre, pulsera, destino).
- Reportar movimiento al sistema institucional de emergencias (por ejemplo, CVOED-IMSS), así como en sistema de información oficiales como el expediente clínico electrónico.

5. Atención en la Zona de seguridad externa

La zona de seguridad externa cumple un papel distinto y complementario a la zona interna: es un espacio de control, recepción, reorganización y transición posterior a la salida del inmueble. Su adecuada operación es indispensable para evitar víctimas secundarias, pérdidas de trazabilidad y desorganización en la atención.

Funciones esenciales que deben realizarse en la zona de seguridad externa:

i. Recepción y concentración segura de personas evacuadas. Recibir de manera ordenada a pacientes, personal, visitantes y acompañantes. Mantener separación funcional entre:
   - Pacientes críticos.
   - Pacientes no críticos.
   - Personal de salud.
   - Público y familiares.
   - Prevenir reingresos no autorizados al inmueble.

ii. Reevaluación clínica inicial (triage post-evacuación):
   - Realizar valoración clínica rápida de los pacientes evacuados.
   - Identificar deterioro clínico posterior a la evacuación.
   - Reclasificar prioridades para traslado interhospitalario o atención inmediata.
   - Detectar lesiones o afectaciones relacionadas con el proceso de evacuación.

iii. Estabilización básica y soporte temporal:
   - Brindar atención médica y de enfermería básica según capacidad disponible.
   - Administrar oxígeno, analgesia, fluidos o medidas de soporte inicial.
   - Mantener continuidad mínima del tratamiento en pacientes crónicos o vulnerables.
   - Evitar la saturación de recursos avanzados fuera del hospital.

iv. Organización y priorización de traslados:
   - Consolidar listados de pacientes candidatos a traslado.
   - Priorizar traslados según gravedad, recursos requeridos y disponibilidad.
   - Coordinar asignación de ambulancias y rutas seguras.
   - Evitar traslados simultáneos no controlados.

v. Trazabilidad y control de pacientes y personal:
   - Registrar: Identidad del paciente, hora de evacuación, ubicación en la zona externa, destino final.
   - Mantener control del personal evacuado y reasignado.
   - Garantizar trazabilidad institucional y legal.

vi. Coordinación interinstitucional. Mantener enlace permanente con:
   - CRUM / COE.

- Protección Civil.
- Servicios de ambulancias.
- Unidades receptoras.
- Ajustar decisiones de traslado según evolución del evento.
- Facilitar interoperabilidad entre instituciones.

vii. Comunicación institucional y con familiares:
- Designar a un vocero para proporcionar información clara, oportuna y centralizada (regularmente designado en la OOAD o por Nivel Central)
- Evitar información contradictoria o no autorizada.
- Canalizar a familiares a puntos de información definidos.
- Registrar solicitudes y reportes relevantes.

viii. Seguridad y control del área. Hay que asegurar que la zona externa:
- Esté fuera de áreas de riesgo (estructural, fuego, explosión, derrames).
- Permita movilidad segura de camillas y ambulancias.
- Controlar accesos, circulación vehicular y peatonal.

ix. Gestión de recursos y logística básica:
- Distribuir insumos básicos (agua, cobijas, EPP, iluminación).
- Asegurar disponibilidad de equipos portátiles.
- Coordinar relevo del personal y manejo de fatiga.
- Identificar necesidades emergentes.

x. Documentación y reporte
- Registrar incidencias ocurridas en la zona de seguridad externa.
- Reportar al sistema institucional correspondiente (p. ej., CVOED).
- Documentar tiempos, decisiones críticas y recursos utilizados.
- Generar insumos para el análisis post-evento.

Cierre de la fase de respuesta y recuperación

Tras una evacuación hospitalaria parcial o total, la fase de cierre y recuperación tiene como objetivo restablecer la operación de manera segura, ordenada y progresiva, garantizando la continuidad de la atención médica, la rendición de cuentas y la mejora institucional.

Dirección del hospital: es responsable de declarar formalmente el cierre de la fase de respuesta, autorizar la transición a la recuperación y definir la reapertura parcial o total del establecimiento, priorizando servicios y procesos críticos, garantizando respaldo institucional a las decisiones clínicas y operativas adoptadas, así como la comunicación oficial con el personal y las autoridades correspondientes.

Comité Hospitalario de Emergencias: coordina la evaluación integral posterior al evento, consolidando información clínica, operativa, estructural y funcional, estableciendo criterios técnicos para el retorno progresivo a la operación, y elaborando el informe final del evento que documenta decisiones, tiempos, incidencias y lecciones aprendidas.

Unidad Interna de Protección Civil: en coordinación con las autoridades externas de Protección Civil, realiza la gestión de los dictámenes de seguridad del inmueble, verifica condiciones para el reingreso seguro de personal y pacientes, identifica daños y vulnerabilidades, y define las medidas correctivas necesarias como parte del fortalecimiento de la gestión del riesgo.

Servicios clínicos y de enfermería: dan continuidad a la atención clínica de los pacientes evacuados o reubicados, evalúan desenlaces clínicos, necesidades de intervenciones ante patrones de respuesta humana alterados y posibles eventos adversos asociados a la evacuación, y participan en la planeación y ejecución del retorno gradual de los servicios, conforme a la capacidad instalada y al riesgo residual.

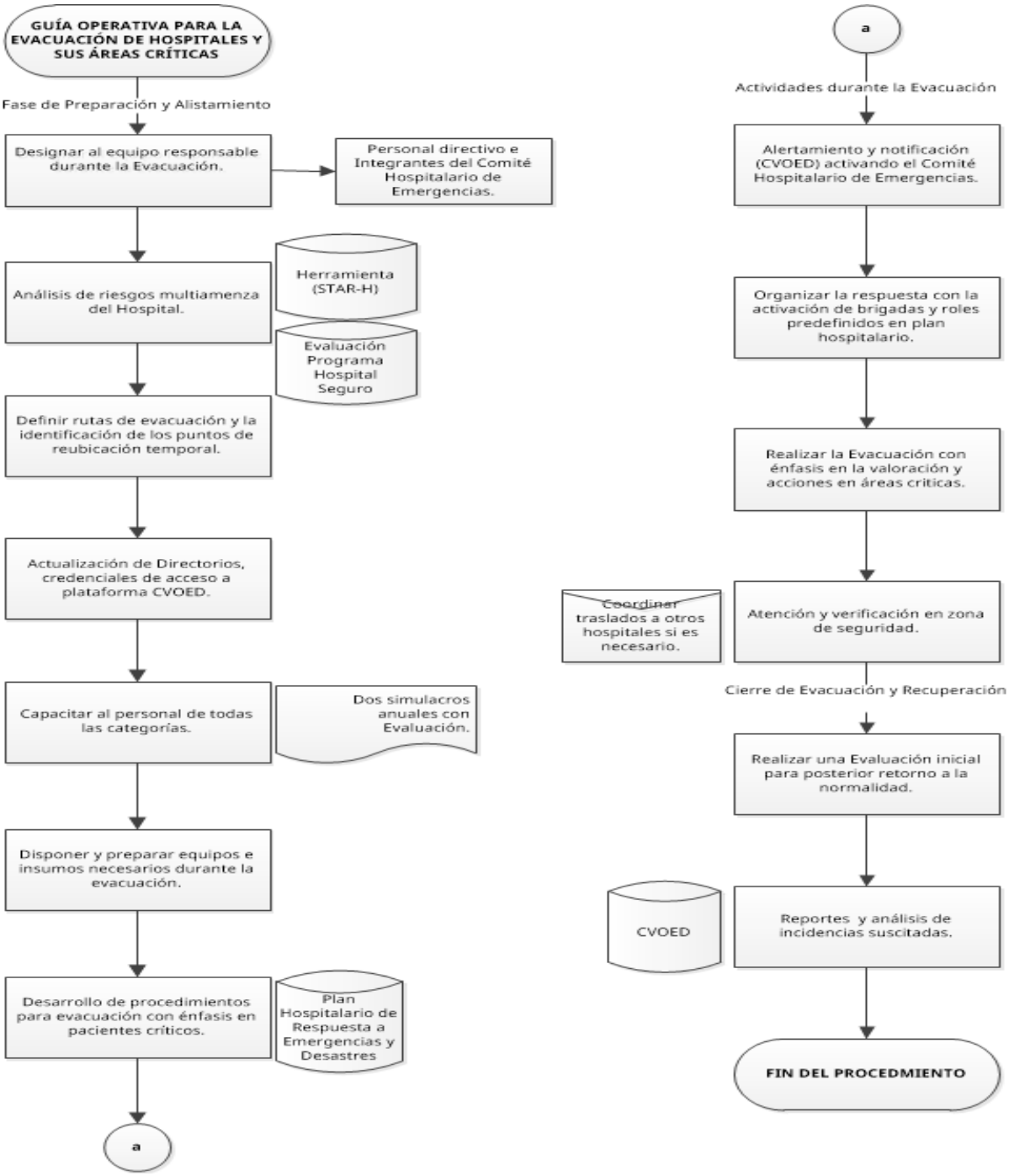
Áreas de conservación, biomédica, servicios generales y abasto: son responsables de rehabilitar la infraestructura y los servicios críticos, verificar el funcionamiento seguro de instalaciones y equipamiento, reponer insumos utilizados durante la respuesta y restablecer las cadenas de suministro necesarias para la operación normal del hospital.

Áreas de trabajo social, comunicación institucional y seguridad: garantizan una comunicación clara, oportuna y centralizada con pacientes y familiares, mantienen el control de accesos durante la reapertura progresiva y contribuyen al orden, la protección y la estabilidad institucional en la fase de recuperación.

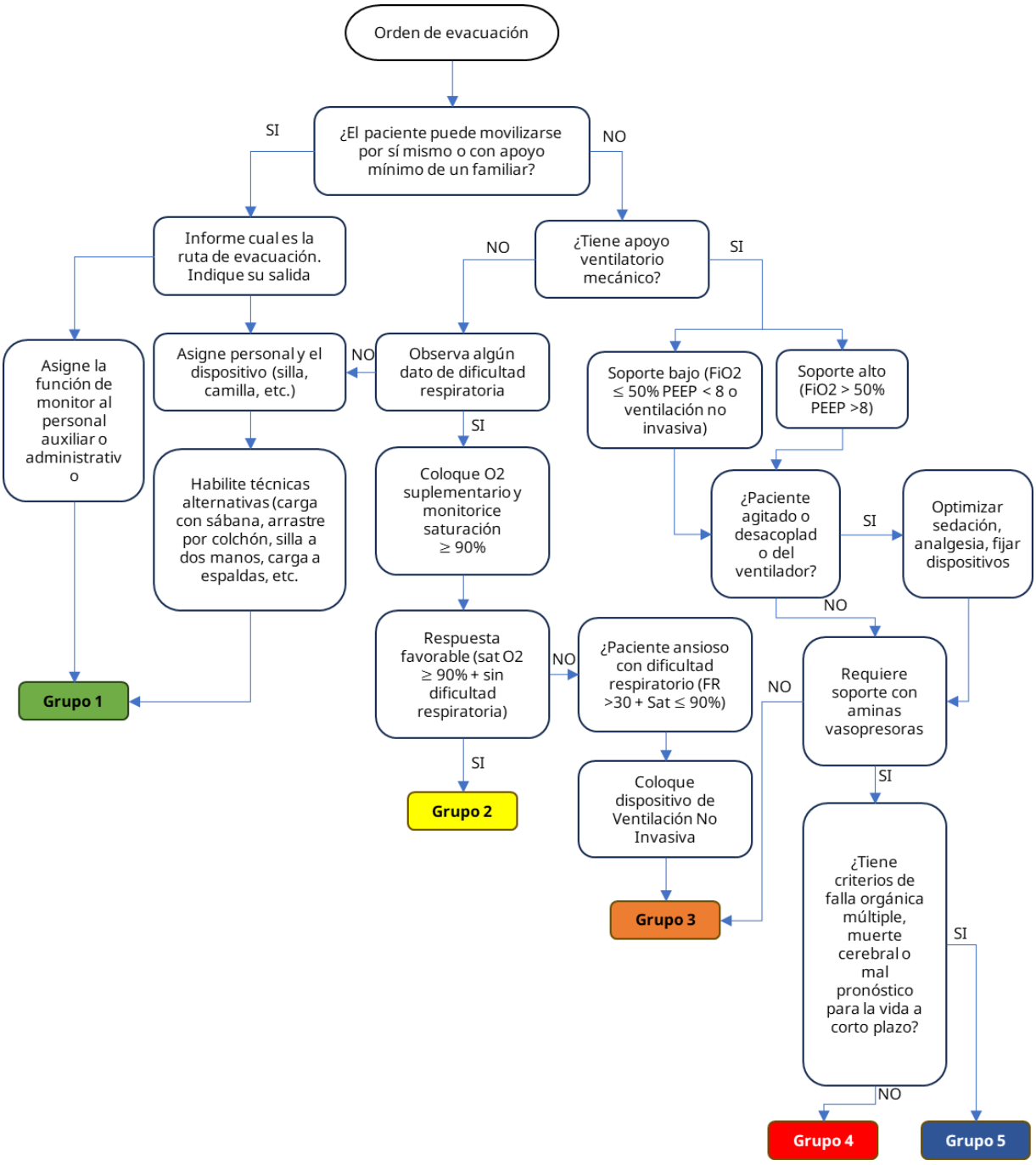
Sistemas de información y nivel central: aseguran el cierre de los registros de evacuación, la trazabilidad clínica y administrativa de pacientes y recursos, el análisis de la información generada y la incorporación de las lecciones aprendidas al fortalecimiento de lineamientos, protocolos y capacidades institucionales.

Anexos

Anexo 1. Flujograma



Anexo 2. Algoritmo para realizar el triage para evacuación de áreas críticas



Fuente: Organización Panamericana de la Salud. EVAC-H. Evacuación de hospitales y sus áreas críticas. Washington, D.C.: OPS; 2024.

Referencias

1. Evacuación de Unidades Hospitalarias. PIFED. 2014. https://cvoed.imss.gob.mx/COED/home/normativos/DPM/archivos/evacuacion_hospitales/Evacuacion%20de%20unidades%20hospitalarias.pdf
2. Cruz-Vega F, Loría Castellanos J, Sánchez Echeverría JC, et al. Hospital evacuation with emphasis on critical areas. Mexico: Berit FGV; 2018. 107pp.
3. Cruz-Vega F, Loría Castellanos J, Sánchez Echeverría JC, et al. Evacuación de Hospitales con énfasis en áreas críticas. Mexico: Berit FGV; 2018. 107pp.
4. Organización Panamericana de la Salud. EVAC-H. Evacuación de hospitales y sus áreas críticas. Washington, D.C.: OPS; 2024. https://www.paho.org/es/documentos/evac-h-evacuacion-hospitales-sus-areas-criticas
5. Secretaría de Salud de México. Manual para la Atención a la Salud ante Desastres. CENAPRECE.
6. Instituto Mexicano del Seguro Social. Plan Institucional Frente a Emergencias y Desastres. 2024.
7. Organización Mundial de la Salud. Marco de gestión del riesgo de emergencias y desastres de salud. 2021.
8. Ministerio de Salud de Nicaragua. Guía para la Elaboración de Planes de Emergencias Hospitalarios. 2005 (adaptado).

Recursos

Video. Evacuación de Hospitales. IMSS. 2011. Disponible en: https://youtu.be/BB81-ngFEoY?si=4KmYgWOrs4e69azj

Curso: Sistema de Comando de Incidentes para Hospitales (SCI-H). Campus Virtual de Salud Pública. OPS. disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/sistema-de-comando-de-incidentes-para-establecimientos de salud.

Curso: Marco de respuesta multiamenaza: Planeamiento hospitalario para la respuesta a emergencias en salud y desastres. Campus Virtual de Salud Pública. OPS. disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/respuesta-multiamenaza-planeamiento-hospitalario-emergencias

Curso: Curso virtual de evaluación de establecimientos de salud a través del índice de seguridad hospitalaria (ISHv2). Campus Virtual de Salud Pública. OPS. disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/evaluacion-de-establecimientos-de-salud

Contacto

Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED)
(24/7 los 365 días del año)
Teléfonos:
55 52 62 53 68 (directo)
55 52 38 27 00 (conmutador), Extensiones: 19081, 19083, 10315, 19832 y 19831
55 80 03 58 24 (WhatsApp)
Sitio web: https://cvoed.imss.gob.mx
Correo electrónico: cvoed.coord@imss.gob.mx

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS)
55 5095 3200 línea nacional para reportes relacionados con fuentes radiactivas robadas o emergencias radiológicas.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
55 11 03 60 00 ext. 72034

Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil / Sistema Nacional de Protección Civil (CENACOM), 24 horas 365 días del año
51 28 00 00 ext. 36422 y 36428